23. NOTAS PRÁCTICAS ANTES DEL ABORDAJE DEL HÍGADO

DURACIÓN : 06:13 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, los practicantes aprenderán a explorar el hígado teniendo en cuenta su integración en el conjunto del cuerpo y sus relaciones con el corazón y las estructuras circundantes. Los conceptos de motilidad embrionaria son el núcleo de la práctica, donde la técnica comenzará con un contacto neutro y progresará hacia un enfoque más profundo, favoreciendo así la respiración primaria y la emergencia de un proceso terapéutico. Los participantes serán guiados sobre la importancia de trabajar en relación con los fulcros embrionarios, especialmente la línea media y el corazón, para dinamizar los sistemas vasculares y neurológicos, y mejorar así la eficacia de su tratamiento.

PRÁCTICA ANTES DEL ABORDAJE DEL HÍGADO

En esta sesión, exploraremos el **hígado** en relación con su **entorno global**. Es esencial no adoptar un enfoque demasiado **selectivo** o **local**.

El hígado juega un papel central en la organización de la cavidad posterior de los **epiplones**, el establecimiento del **estómago**, el eje del **bazo** y el **epiplón mayor**. Practicaremos sobre el hígado teniendo en cuenta su relación con el **corazón** y la cavidad posterior de los epiplones, utilizando una toma de mano adaptada.

El objetivo es permitir que el hígado recupere su **motilidad**, ya que es esta motilidad la que crea su función. Comenzaremos con un contacto **neutro** y superficial, que se volverá progresivamente más profundo a medida que se manifieste la **respiración primaria**. El encuentro de estos dos neutros es lo que hace emerger el **proceso terapéutico**.

El hígado es crucial en la organización del embrión, especialmente en el eje **transversal** y el establecimiento del eje **gastro-duodeno-pancreático-lineal**, gestionando así todo el movimiento. Este balanceo, que abordamos anteriormente con la red **venosa** y **arterial**, es un movimiento de desarrollo esencial para el crecimiento. El hígado se mueve sobre sí mismo, no por rotación, sino por **desplazamiento**, lo que le confiere una fuerza de desarrollo.

Esta motilidad de origen embrionario es fundamental. Cuando colocamos nuestras manos, debemos situarnos en un **fulcro** donde todo el sistema pueda desarrollarse. Si nos limitamos a un enfoque local, perdemos de vista el fulcro original.

Cuanto más nos acercamos al fulcro embrionario, más accedemos a esta fuerza, y más información puede proporcionarnos el cuerpo, porque la conoce. Una frecuencia elevada favorece la **potencia regeneradora**. Considere la palabra "fulcro" como una **función** más que como un simple punto de apoyo.

La **línea media**, por ejemplo, es un fulcro para la totalidad. Hemos identificado la zona del corazón como un fulcro embrionario, que no puede reducirse a un simple punto.

El trabajo sobre la motilidad ligada al desarrollo del **cerebro** puede servir como herramienta. Recordemos las curvaturas, ese "tai chi" del cerebro:

- **Expansión**
- **Flexión cefálica**
- **Flexión cervical**
- **Flexión póntica**
- **Telencefalización**

La fase de telencefalización es crucial, ya que induce el enderezamiento y el establecimiento de la **línea blanca anterior**. Esto implica la formación de la **estrella**.

Podemos trabajar únicamente sobre la motilidad o utilizar **puntos específicos** como:

- La punta del **monotocorte**
- El **supraoccipucio**
- La base del **occipucio**
- El **preesfenoides**

Estos puntos están relacionados con estos desarrollos. Por ejemplo, la punta del monotocorte es un punto de referencia importante en la **flexión submencefálica**.

Así puedo buscar el **punto de silencio** en el sistema en desarrollo, en función de los puntos de apoyo sobre los que me posiciono. Algunas fases se desarrollarán simultáneamente, ilustrando la **sincronicidad** del desarrollo.

En cuanto al desarrollo del cerebro, un vestigio importante se encuentra a nivel del **sistema mesentérico**. El eje **vitelino** o **mesentérico** es crucial para redinamizar un cerebro en desarrollo.

A nivel vascular, es importante señalar que el cerebro depende enteramente del corazón para su función y formación. El corazón informa continuamente al cerebro, y una **pulsación** está presente en este último.

Tenga en cuenta la imagen del **septum transverso** que se enrolla con el establecimiento del hígado, integrado con la **vesícula vitelina**. El establecimiento de la **cavidad amniótica** es el resultado de nuestro trabajo anterior.

Existe un movimiento de motilidad de desarrollo generado por el hígado, que organiza todo el sistema **hepato-gastro-duodeno-pancreático-lineal**. Observamos el balanceo del corazón sobre su eje izquierdo, un movimiento inverso a nivel hepático global, y una contrarrotación a nivel digestivo.

Primero trabajaremos en este gran centro de organización **subdiafragmático**, estableciendo la cavidad posterior de los epiplones. Luego, examinaremos la relación entre el hígado y el corazón, que serán nuestros dos puntos de trabajo.

Tenemos la **impronta cardíaca**, la **impronta pulmonar** y la enorme **impronta hepática**. Realizaremos un trabajo sobre el hígado en relación con el establecimiento del corazón y del intestino, adoptando un enfoque **biodinámico**.

Esto significa que colocaremos nuestras manos y dejaremos que el movimiento se produzca. Podremos tener un movimiento que busca o un movimiento que expresa su originalidad. Daremos este punto para que el sistema pueda reorganizarse.

El hígado es una **especialización** a considerar como una **expansión fractal** del intestino. Se compone de un conjunto de **conductos biliares** con dos tipos de información:

- Una información de tipo **vascular**, correspondiente al hígado de tipo **portal**.
- Una cara completamente roja puede indicar un problema hepático de tipo **mesodérmico**.
- Una cara completamente amarilla puede señalar un problema hepático de tipo **endodérmico**.

Estos dos enfoques permiten comprender el sistema de manera complementaria.